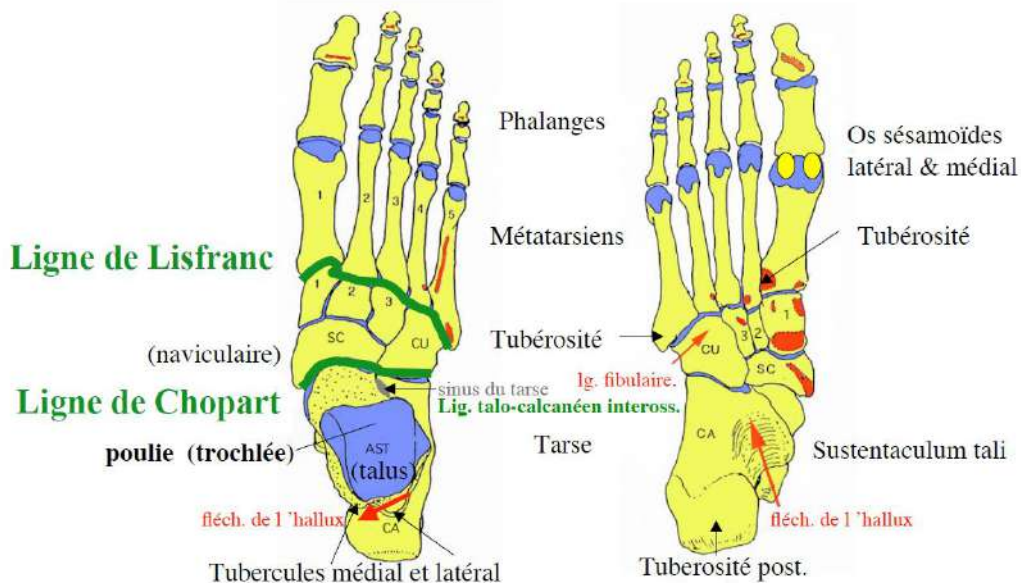


EXAMEN CLINIQUE DE LA CHEVILLE ET DES PIEDS

CONNAISSANCES DE BASE

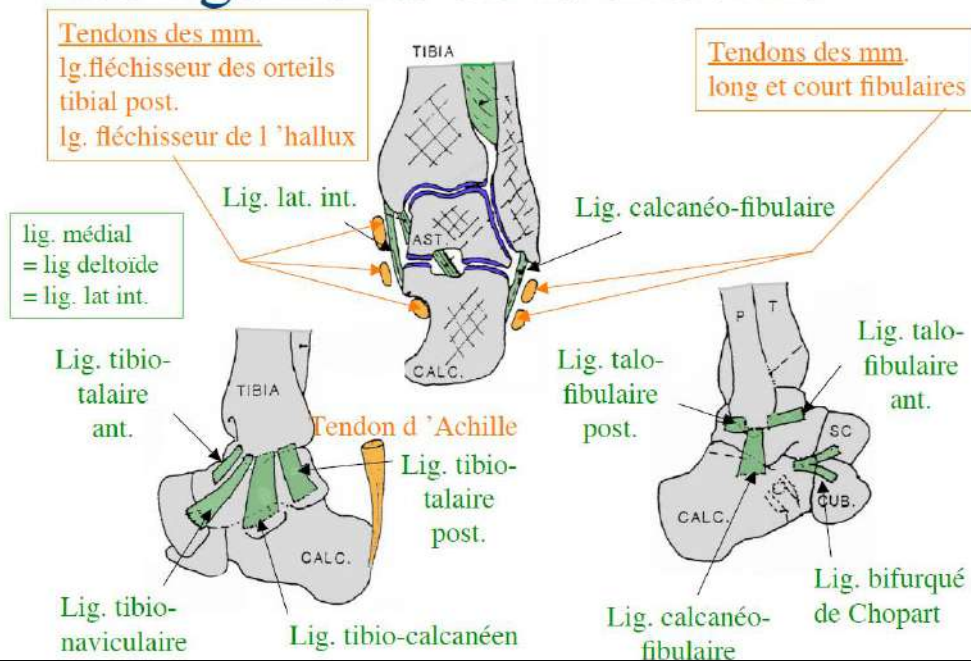
Rappel des Os du Pied



Ligament deltoïdien (ou triangulaire):

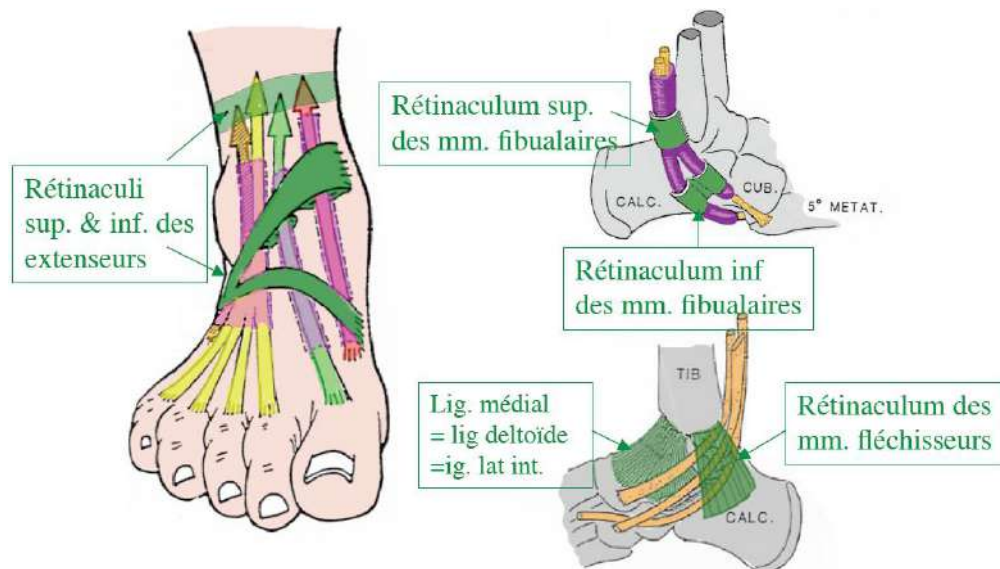
Ligaments tibio-talaires antérieur et postérieur, tibio-naviculaire et tibio-calcanéen
Malléole médiale -> astragale et aux os du tarse proximal
Opposition à une éversion du pied

Les ligaments de la cheville

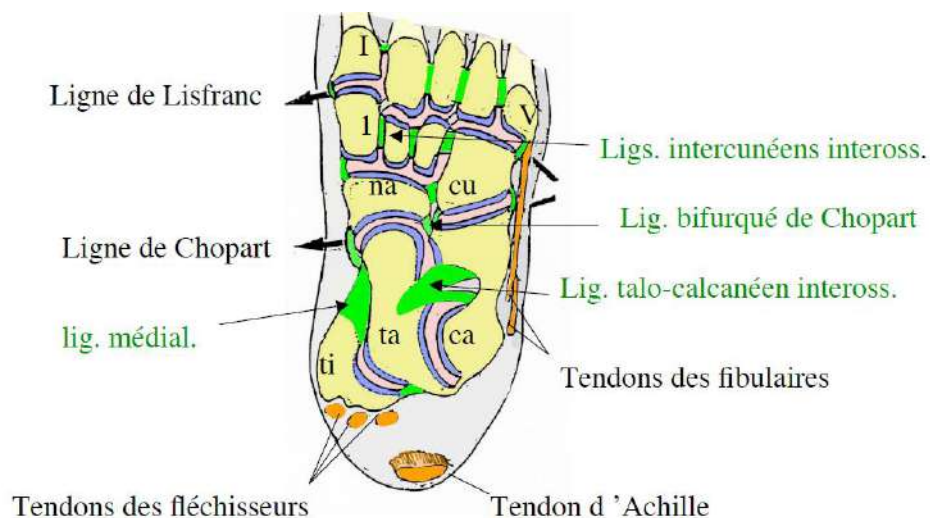
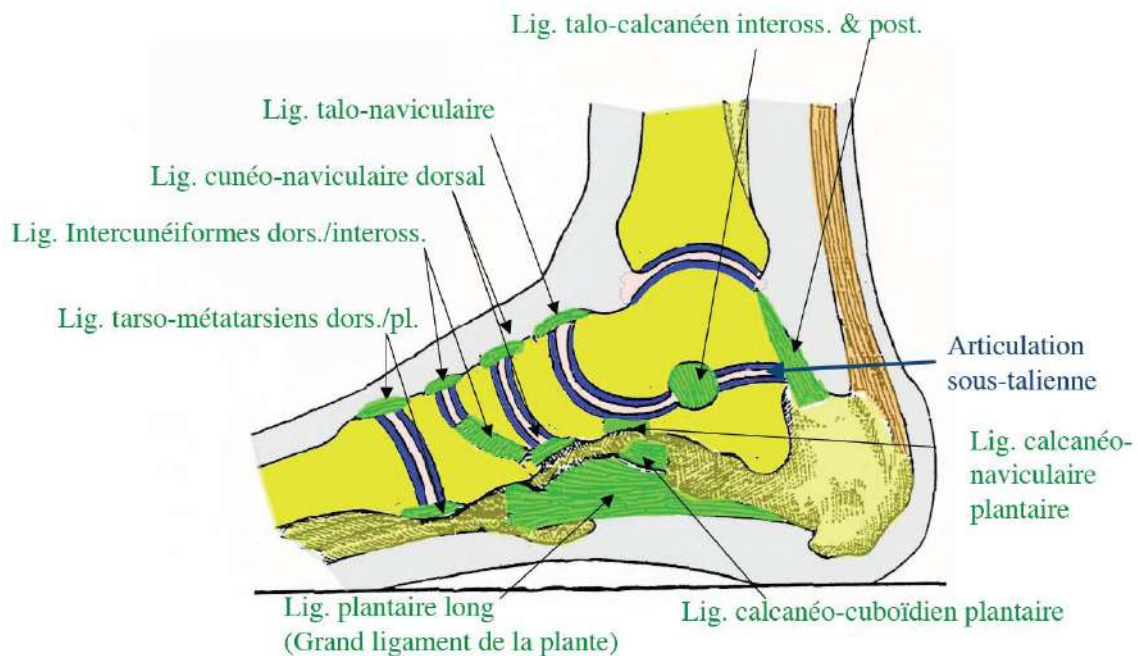


Ligament collatéral latéral de la cheville:

Antérieurement: ligament talofibulaire antérieur: le plus souvent lésé par une inversion du pied
Médialement: ligament calcanéo-fibulaire
Postérieurement: ligament talofibulaire postérieur



Les ligaments du tarse



Durant la réalisation du status, l'examineur ne doit pas oublier de toujours examiner et tester les deux pieds.

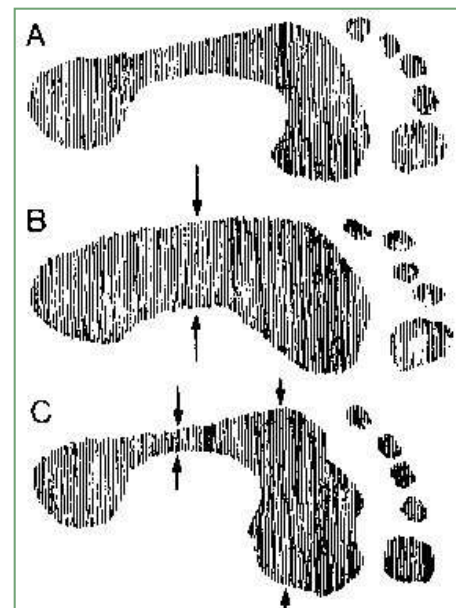
INSPECTION

- Angle du pas:
Lors de la marche, le pied n'est pas droit. Il présente toujours une rotation externe de 15° .
- Cycle de la marche:
3 parties:
 1. Le talon appuie.
 2. Phase intermédiaire
 3. Partie finale: la partie antérieure du pied appuie
- Boiterie: *Est-ce que le patient boîte?*
Deux types de boiterie
 - Antalgique: le patient ressent une douleur. En conséquence, il s'appuie moins longtemps sur le pied douloureux. Il change rapidement de pieds.
 - Musculaire: atteinte des fessiers. Le patient peine à soutenir le bassin. Le bassin tombe.



- Steppage: *Est-ce que le patient présente un steppage?*
Deux types: musculaire ou neurologique:
 - Neurologique: défaut d'innervation du muscle tibial antérieur responsable de l'extension du pied. Le patient n'arrive pas à étendre le pied pour le poser à plat. Il doit tirer son pied en arrière pour le poser.
 - Musculaire: le patient a suffisamment de force pour poser le talon (donc contracter le muscle pour soulever le pied) Mais il n'a pas assez de force pour maintenir la cheville fléchi.

- Appuie: *L'appuie est-il complet et symétrique?*
Utiliser un podoscope et observer si:
 - Si $1/3$ du pied appuie.
 - Si le creux (partie qui n'appuie pas) représente $2/3$ du pied.
 Image: A) pied normal, B) appuie fort, C) appuie faible



- Déformations: *Les chevilles présentent-elles des déformations?*
 - Axe différent:
 - Valgus: partie distale du pied s'oriente vers l'extérieur
 - Varus: partie distale du pied s'oriente vers l'intérieur
 - Tendon d'Achille: observer le tendon d'Achille
 - A plat: le tendon d'Achille n'est pas droit, il y a un petit angle vers l'extérieur, en valgus à 5° .
 - Sur la pointe des pieds: le tendon d'Achille se déplace, il est corrigé en varus.



- Orteils:

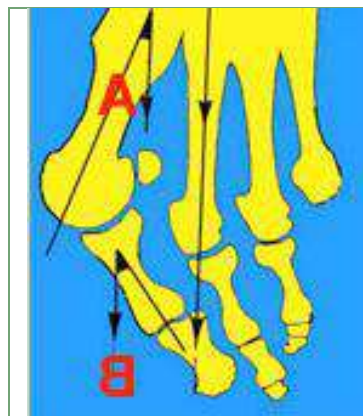
- Taille: *La taille des orteils est-elle décroissante depuis l'intérieur vers l'extérieur?*

La longueur de l'hallux n'est pas importante. Des orteils normales présentent une décroissance orteils depuis l'intérieur vers l'extérieur.

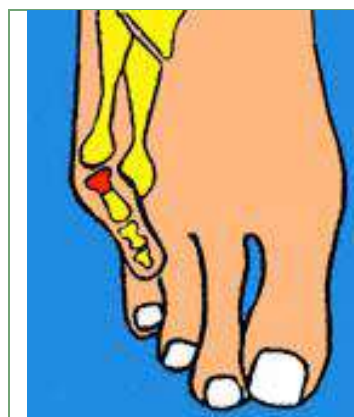
- Callosité: chercher des callosités dans les zones du pied qui servent de support de charge:
 - Talon
 - Métatarsiens 1-5
- Orteils en griffe
- Ongle incarné: ongle qui s'introduit dans la peau



- Hallux valgus:
 - Hallux dirigé vers l'intérieur
 - Cause: métatarse valgus, c'est-à-dire que le métatarse se dirige intérieurement. Cette ration est provoquée par des pieds plats ou un défaut congénital. Les chaussures fermées peuvent favoriser le développement de l'hallux valgus. C'est une affection très fréquente (50% des consultations).
- Quintus varus: Le petit orteil est dirigé vers l'intérieur



Hallux valgus



Quintus varus



Le patient s'assied sur le lit.

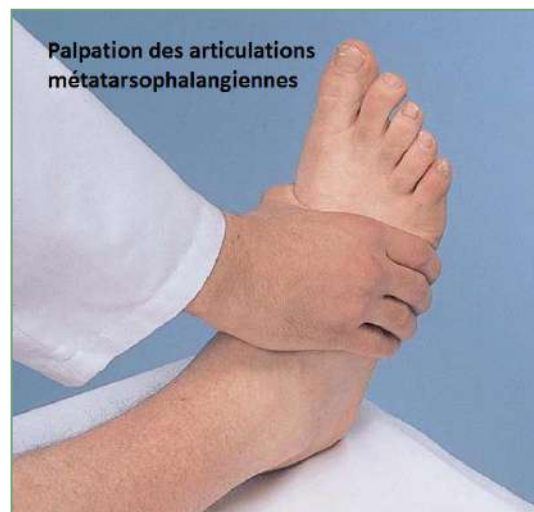
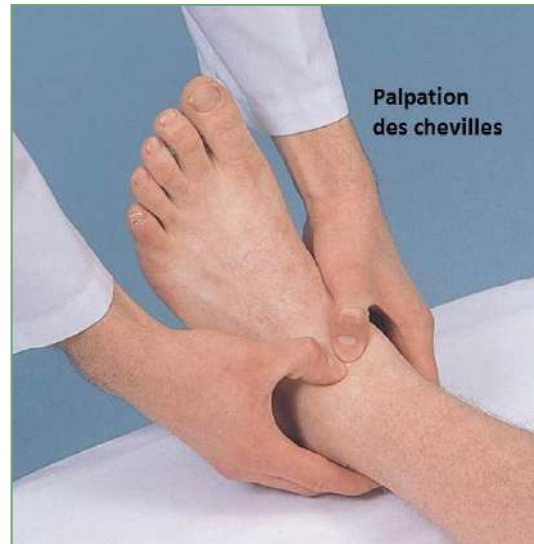
- Autres atteintes: observer la présence:
 - D'hématome
 - De torsions
 - De nodules
 - Des gonflements
 - D'excroissances, cors et durillons
 - Des mycoses
- Observer les tendons, entre les orteils, dans les espaces interdigitaux et les ongles.

PALPATION

L'examineur réalise une palpation depuis la partie proximale en direction distale.

L'examineur palpe:

- **Malléoles interne et externe:**
 - L'examineur palpe avec ses pouces et recherche des douleurs ou des œdèmes
- **Insertions des ligaments latéraux:** en cas d'entorse, la palpation est douloureuse.
- **Articulation tibiotalaire :** rechercher d'un épanchement.
- **Tendon d'Achille:** rechercher des nodules ou des douleurs
- **Articulation sous-talienne (entre le talus et le calcanéum)**
- **Articulations de Chopart ou de Lisfranc:** palpation (théorique)
- **Articulation métatarsophagiennes:**
 - L'examineur serre l'avant-pied entre le pouce et les doigts. Il comprime juste au-dessus des têtes des 1er et 5e métatarsiens
 - Affections:
 - Douleur à la pression: signe précoce de polyarthrite rhumatoïde
 - Inflammation aiguë de l'articulation métatarsophagienne du gros orteil: goutte
- **Métatarsiens:**
 - L'examineur place son pouce sur le dos du pied et l'index sur la plante. En comprimant le pouce et l'index, il palpe la tête des cinq métatarsiens et les sillons les séparant.
 - Affections:
 - Douleur spontanée: métatarsalgie (traumatisme, rhumatisme et ischémie)
 - Douleur des têtes des 3e et 4e métatarsiens sur la plante des pieds: névrome de Morton
- **Aponévrose plantaire à la recherche de fasciite:**
 - Le patient étend les orteils et l'examineur palpe depuis la partie postérieure vers la partie antérieure du pied.



L'examineur identifie les poulx:

- **Tibial postérieur:** derrière la malléole interne
- **Pédieux:** sur le dos du pied (mais il n'est pas présent chez tout le monde)

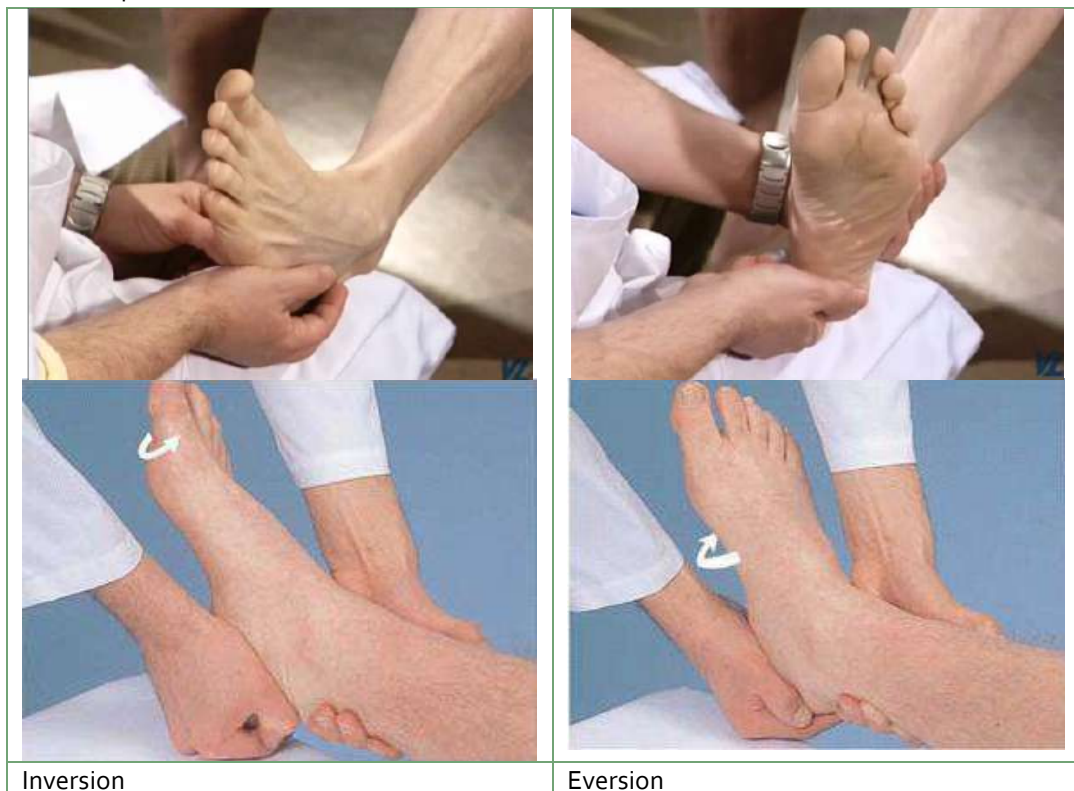
MOBILISATION

Tout les mouvements sont réalisés volontairement et sont contrôlés passivement par l'examineur.

- Articulation tibiotalaire:
 - L'examineur demande au patient de fléchir et d'étendre son pied.
 - L'examineur saisit le pied du patient et réalise les mêmes mouvements passivement.



- Cause: les douleurs pendant les mouvements de la cheville et du pied aide à localiser une possible arthrite.
- Articulation sous-talaire (entre le talus et le calcanéum):
 - L'examineur immobilise la cheville d'une main et sais le talon de l'autre.
 - L'examineur demande au patient de tordre la cheville en-dedans et en-dehors.
 - L'examineur saisit le pied du patient et réalise les mêmes mouvements passivement.



Inversion

Eversion

- Articulation de Chopart:
 - Cette articulation doit être un peu mobile.
 - L'examineur saisit le calcanéum et l'immobilise le talon. L'examineur réalise une rotation des deux côtés, inversion et éversion.



- Articulation de Lisfranc:
 - Les ligaments transverses rendent cette articulation immobile.
 - L'examineur saisit le calcanéum et l'immobilise le talon. Il saisit distalement le pied et essaie de réaliser des rotations.
- Articulations métatarsophalangiennes:
 - L'examineur immobilise la cheville d'une main et fléchit les orteils par rapport aux pieds.
- Articulations interphalangiennes proximales et distales

Mouvements

FLEXION 30-50° EXTENSION 10-15°	INVERSION 20° EVERSION 5°	ROT. INT. 10° ROT. EXT. 10°
--	--	--

27